REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Anemias Hemolíticas

Doença falciforme, talassemias, membranopatias, enzimopatias e hemólises adquiridas em uma página

MAIS COBRADO

- 1º Doença falciforme: **febre**, crises e profilaxia
- 2º **Coombs direto** separa imune × não imune
- 3º **Traço talassêmico** × anemia ferropriva
- 4º **PTT/SHU**: esquizócitos + plaquetopenia

1 Reconhecer a hemólise

hemácia vive ~120 dias

Anemia + reticulocitose + **LDH ↑** + **bilirrubina indireta ↑** + **haptoglobina ↓** = hemólise. Próximo passo: **Coombs direto** e **esfregaço**.

	Intravascular	Extravascular
Onde	Dentro do vaso	Macrófagos do baço/fígado
Pistas	LDH muito ↑, **hemoglobinúria**, hemossiderinúria	**Esplenomegalia**, esferócitos
Exemplos	G6PD na crise, PTT/SHU, HPN, ABO, prótese	Esferocitose, AHAI quente, DF, talassemias

ESFERÓCITOS
Esferocitose ou AHAI quente

ESQUIZÓCITOS
MAT (PTT, SHU, CIVD), prótese

HEINZ / MORDIDAS
Deficiência de G6PD

2 Doença falciforme

Glu → Val na β-globina · autossômica recessiva

SS e **S/β⁰**: graves · **SC**: retinopatia e necrose óssea, baço persiste · **AS**: traço, não é doença. Pezinho: **FS** = DF · **FAS** = traço · **FSC**. Eletroforese confirma **após 6 meses**.

HbS polimeriza → **vaso-oclusão** + **hemólise**. **HbF protege**. **Asplenia funcional** em 94% aos 5 anos; pneumococo > 70% das infecções. Hb basal 7–11,5 g/dL na SS.

Quadro	Pista	Conduta
Febre	Risco de sepse	Avaliar em **até 4 h**, hemocultura, **antibiótico parenteral** sem esperar; internar < 5 anos com > 38,3 °C
Crise dolorosa	Dor óssea/abdominal	Analgesia **imediata** e escalonada (opioide se intensa), sem hiper-hidratar
STA	**Infiltrado novo** + febre ou sintomas	Cefalosporina 2ª/3ª (+ macrolídeo), **O_2 para $SatO_2$ > 92%**, fisioterapia, transfusão se piora
Sequestro	Baço cresce + Hb despenca	Cristaloide + transfusão **5 mL/kg**; esplenectomia (PCDT: após o 1º)
Aplástica	**Reticulócitos baixos** · parvovírus B19	Suporte; hemácias fenotipadas
AVC	Déficit focal	**Exsanguineotransfusão** (HbS < 30%, Hb ≤ 10)
Priapismo	Sem melhora em 2 h	Internar · > 4 h: urologia

Penicilina 3 meses–5 anos (125 → 250 mg 12/12 h ou benzatina 50.000 UI/kg) · vacinas · **Doppler 2–16 anos**: ≥ 200 cm/s → transfusão crônica · **hidroxiureia** (2024): **a partir de 9 meses** na SS/Sβ⁰, mesmo sem sintomas; 15 → 35 mg/kg/dia · TCTH com irmão HLA é a cura.

3 Talassemias

microcitose por falta de cadeia de globina

β-menor: Hb > 10, hemácias e RDW normais, VCM muito baixo, **HbA2 > 3,6–4%**. **β-maior (Cooley):** sintomas do 3º mês, Hb < 7, deformidades de face/crânio → transfusão (Hb pré 9,5–10,5) + **quelação de ferro**.

α: 1 gene = silencioso · 2 = traço · 3 = **doença da HbH** · 4 = **Hb Bart → hidropsia fetal**.

4 Membrana, enzimas e adquiridas

ESFEROCITOSE
Anemia + icterícia + esplenomegalia + litíase precoce · **CHCM > 34**, **Coombs –**, EMA ou fragilidade osmótica · esplenectomia **conforme a gravidade** (grave: 4–6 anos), vacina antipneumocócica antes.

G6PD
Ligada ao X · hemólise 24–72 h após **infecção, fava, primaquina, dapsona, sulfa, rasburicase** · dosar **fora da crise** · pesquisar antes da primaquina (malária vivax).

AHAI QUENTE × FRIA
Quente: **IgG**, esferócitos → **prednisona 1 mg/kg**, rituximabe. Fria: **IgM/C3**, Mycoplasma, EBV, linfoma → evitar frio; corticoide não funciona.

HPN
Hemólise + **trombose atípica** (Budd-Chiari) + falência medular · citometria **CD55/CD59** · eculizumabe.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Toda febre na DF é emergência:** antibiótico parenteral sem esperar exames.
2. **Crise aplástica ≠ sequestro:** aplástica tem reticulócitos baixos; sequestro tem baço grande.
3. **Não transfunda** crise dolorosa não complicada: anemia crônica sozinha não indica.
4. **Hiper-hidratação** na crise dolorosa pode precipitar STA.
5. **STA começa como crise dolorosa:** reavalie o tórax todo dia.
6. **Leucocitose na DF** nem sempre é infecção.
7. **Baço palpável no adulto com DF:** pense em SC ou S/β-talassemia.
8. **Esferócitos em dois lugares:** Coombs – = esferocitose; Coombs + = AHAI.
9. **Microcitose com ferritina normal:** pense em talassemia, não dê ferro.
10. **G6PD normal na crise** não exclui: repita fora da hemólise.
11. **Hiper-hemólise** pós-transfusão: não transfundir; corticoide e imunoglobulina.
12. **SHU típica:** antibiótico na fase diarreica se associa a mais SHU.
13. **PTT:** troca plasmática sem esperar o ADAMTS13; evite plaquetas.
14. **CIVD** tem TP/TTPa alargados e fibrinogênio baixo; PTT/SHU não.

Contas e números

Índice reticulocítico = ret % × (Ht ÷ 45) ÷ fator (≈ 2 com Ht 25%): < 2 produção · > 2,5–3 hemólise
ADAMTS13 < 10% = PTT · **HbS < 30%** na transfusão crônica
Doppler < 170 anual · 170–199 encurta · ≥ 200 transfusão